

Pose d'un cathéter sus-pubien

WARWIKI

Information pour le patient · Ce que vous devez savoir avant l'intervention

Un cathéter sus-pubien (SPT) est une sonde souple qui draine l'urine de la vessie par une petite ouverture dans le bas-ventre, juste au-dessus du pubis, sans passer par l'urètre. Ce document explique pourquoi il est posé, comment vous préparer et ce que vous pouvez attendre.

À propos de cette intervention

La vessie stocke l'urine. Lorsque celle-ci ne peut pas s'écouler normalement — ou que l'urètre doit être mis au repos — une sonde peut être placée directement dans la vessie par le bas-ventre. Parce qu'il évite l'urètre, le cathéter sus-pubien est souvent plus confortable pour un drainage prolongé.

Votre équipe soignante peut recommander un cathéter sus-pubien pour :

- Drainer la vessie si vous ne pouvez pas la vider seul
- Mettre l'urètre au repos après une chirurgie ou une blessure
- Assurer un drainage confortable à long terme (p. ex. en cas de trouble neurologique de la vessie)
- Éviter l'irritation qu'une sonde uréthrale prolongée peut causer
- Permettre une activité sexuelle normale et des « essais mictionnels » (la sonde peut être bouchée pour tester la miction)

Est-ce sans danger ?

Oui. Il s'agit d'une intervention courante et généralement sûre. Pour la sécuriser, la vessie est remplie afin qu'elle se plaque contre la paroi abdominale, et votre équipe utilise habituellement l'échographie et/ou une petite caméra pour guider la sonde loin de l'intestin. La plupart des problèmes — léger saignement, gêne passagère ou crampes vésicales — sont mineurs et disparaissent vite. Signalez toute chirurgie abdominale ou pelvienne antérieure, qui nécessite des précautions supplémentaires.

COMPRENDRE LES TERMES

Sus-pubien

Au-dessus du pubis, dans le bas-ventre — là où sort la sonde.

Vessie

L'organe qui stocke l'urine jusqu'à ce que vous urinie.

Cathéter (sonde)

Tube souple qui draine l'urine. Le cathéter sus-pubien passe par le bas-ventre plutôt que par l'urètre.

Urètre

Le canal qui évacue normalement l'urine. La sonde sus-pubienne le contourne.

Anesthésie locale

Produit anesthésiant injecté dans la peau pour insensibiliser la zone.

Sédation / anesthésie

Médicament pour vous détendre, ou pour vous endormir (anesthésie générale), pendant l'intervention.

Échographie / caméra

Outils (imagerie par ultrasons ou petite caméra dans la vessie) utilisés pour guider la sonde en toute sécurité.

Spasme vésical

Crampe soudaine de la vessie — fréquente après l'intervention et traitable.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Cela dépend de l'approche : certaines poses utilisent un anesthésiant local avec sédation ; beaucoup se font sous **anesthésie générale ou rachianesthésie**, afin que vous soyez endormi ou insensible. Votre équipe vous indiquera laquelle. Des crampes vésicales ou une légère douleur au site sont normales après l'intervention. La pose dure environ 15–30 minutes.

Comment vous préparer (Avant l'intervention)

- **Venez avec la vessie pleine si on vous le demande** — cela sécurise la pose. Votre équipe peut vous demander de boire et de retenir l'urine, ou remplira la vessie au début.
- **Respectez les consignes de jeûne** — si vous recevez une sédation ou une anesthésie générale, vous devrez peut-être ne pas manger ni boire pendant plusieurs heures avant.
- **Prévoyez un conducteur** si vous serez sédaté.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez déjà eu une **chirurgie abdominale ou pelvienne** — le tissu cicatriciel peut modifier le trajet le plus sûr pour la sonde
- Prenez un **anticoagulant** ou avez un trouble de la coagulation — souvent suspendus avant l'intervention
- Pourriez être **enceinte**, ou avez une infection, une allergie aux anesthésiants ou au latex

Déroulement de l'intervention

- 1 Vous êtes installé et recevez l'anesthésie — anesthésiant local avec sédation, ou anesthésie générale ou rachianesthésie. Le bas-ventre est ensuite nettoyé et préparé.
- 2 Votre vessie est remplie de liquide (si elle ne l'est pas déjà) pour qu'elle se plaque contre la paroi abdominale, à distance de l'intestin.
- 3 Guidée par l'échographie et/ou une petite caméra dans la vessie, votre équipe fait une petite incision juste au-dessus du pubis et introduit la sonde dans la vessie.
- 4 Un petit ballonnet est gonflé à l'intérieur de la vessie pour maintenir la sonde en place, puis reliée à une poche de drainage.

Après l'intervention

- L'urine s'écoule dans une poche ; votre équipe vous **montrera comment prendre soin de la sonde et de la peau** avant votre retour à domicile.
- Une légère douleur, des crampes vésicales ou **un peu de sang dans les urines** pendant un ou deux jours est normal.
- Le **premier changement de sonde est effectué par votre équipe**, environ 4 à 6 semaines plus tard. Si la sonde tombe, contactez votre équipe immédiatement — le trajet peut se refermer en quelques heures.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- La sonde **qui tombe** ou cesse de drainer (aucune urine dans la poche)
- Une douleur abdominale croissante, un gonflement ou un saignement important
- Des urines troubles ou malodorantes (signe d'infection)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le cathéter sus-pubien draine la vessie par une petite ouverture du bas-ventre, sans passer par l'urètre — souvent plus confortable au long cours.
2. Pour vous préparer : vessie pleine si demandé, jeûne, un conducteur en cas de sédation, et signalez toute chirurgie abdominale antérieure, anticoagulant ou grossesse possible.
3. La pose se fait sous anesthésie locale avec sédation ou sous anesthésie générale. Votre équipe vous enseigne les soins et effectue le premier changement à 4–6 semaines.